



高齢者の麻酔

症例検討のまとめ

祖父江和哉

術前評価と対応



高齢

MMSE-J、MOCA-Jで認知機能評価を実施する。プレハビリテーション。せん妄対策。

担癌

悪液質には緩和ケア介入が重要である。
貧血の補正。

低栄養

栄養療法とプレハビリを行い、改善を図る。

高血圧

術前に血圧を管理することが必要である。

AF

抗凝固薬の中止と再開計画を立てる。

COPD 気道確保困難

呼吸リハビリと吸入薬の調整を行う。
気道困難への対応策。

麻酔中の問題点と対策



腹腔鏡特有問題

縦隔気腫、気胸、無気肺、高炭酸ガス血症、不整脈、心拍出量の減少、乏尿

高度頭低位

呼吸への影響、眼圧に注意を払うことが重要。

高齢

薬剤感受性が増大するため、減量が必要である。

低栄養

薬物動態の変化に注意を払い、投与量を調整。

高血圧

循環変動が大きい。
観血的動脈圧モニターを使用し、厳重に管理する。

AF

頻脈時にCa拮抗薬やβ遮断薬を使用する。

麻酔中の問題点と対策



COPD

換気設定は入念に行い、肺炎を予防。

貧血管理

輸血の適時判断が必要であることに注意。

腎機能低下

薬剤代謝と低血圧に注意を払うことが重要。

気道確保

挿管戦略を事前に共有しておくことが必要です。

①

せん妄 睡眠障害

環境調整が重要
睡眠障害へはメラトニン受容体刺激薬（ラメルテオン），オレキシン受容体遮断薬（レンボレキサント，スボレキサント）が第一選択

②

AF 高血圧

抗凝固薬の再開
降圧薬の再開
モニタリング

③

肩の痛み 神経障害

早期発見と対策

④

MINS 急性腎障害
呼吸器合併症

Myocardial Injury after
Non-cardiac Surgery

麻酔方法の選択と術後鎮痛戦略



全身麻酔

デスフルランまたはプロポフォール

減量

高齢・低栄養・腎機能低下に応じて調整。

回避

ベンゾジアゼピン系は可能な限り避ける。

観血的動脈圧モニター

循環動態を厳重に監視する。

気道確保デバイス

気道確保方法の検討

多モーダル鎮痛

アセトアミノフェン、NSAIDs
局所浸潤麻酔
末梢神経ブロック